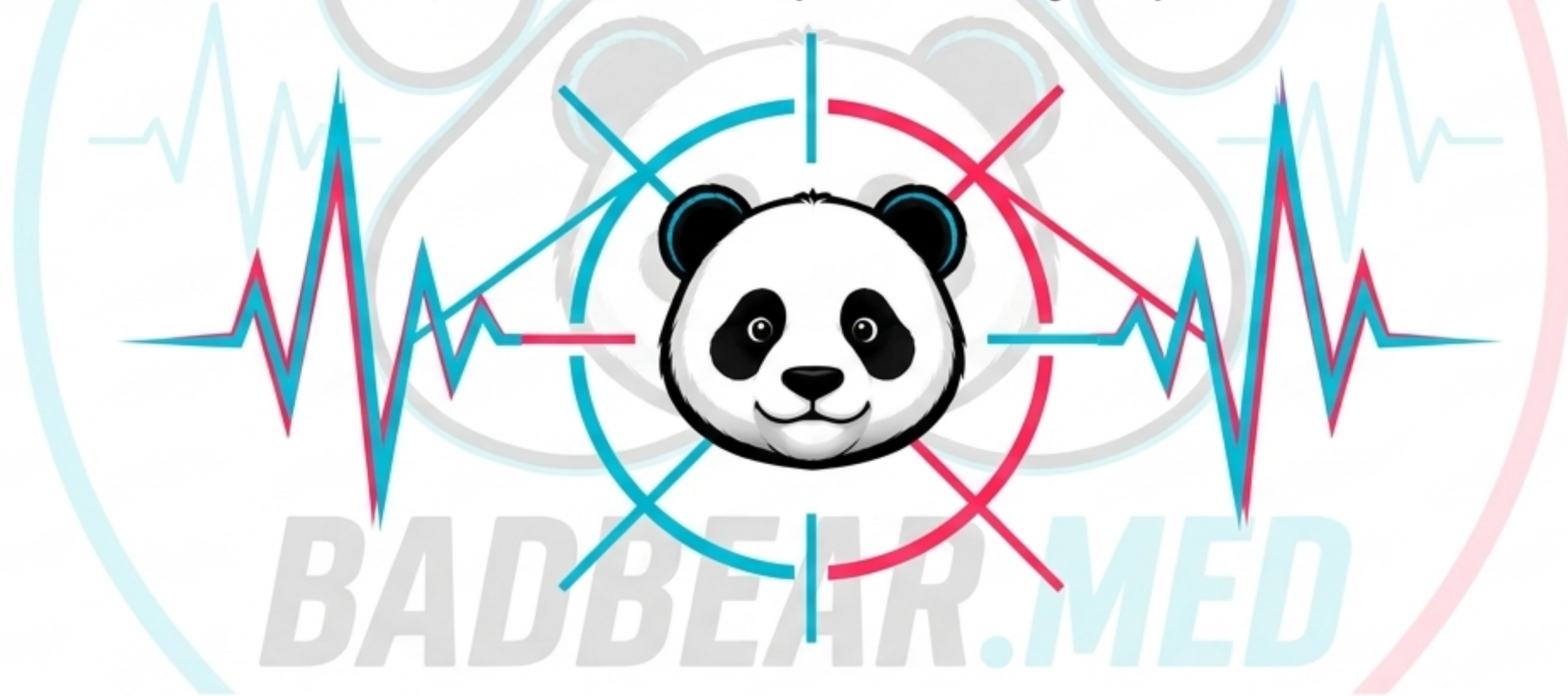


Manejo Integral del Paciente Quirúrgico y Fluidoterapia

Módulo de Estudio: Pre, Trans, Postoperatorio y Equilibrio Hidroelectrolítico



Proyecto BADBEAR.MED | Masterclass Clínica

El Viaje del Paciente Quirúrgico

Reducir la morbilidad y reincorporar al paciente a sus actividades cotidianas. (El trabajo del cirujano no termina con el alta).

Fase 1: Preoperatorio

Preparación, diagnóstico holístico y estratificación de riesgo.

Fase 2: Transoperatorio

Ejecución de la táctica y técnica quirúrgica planeada.

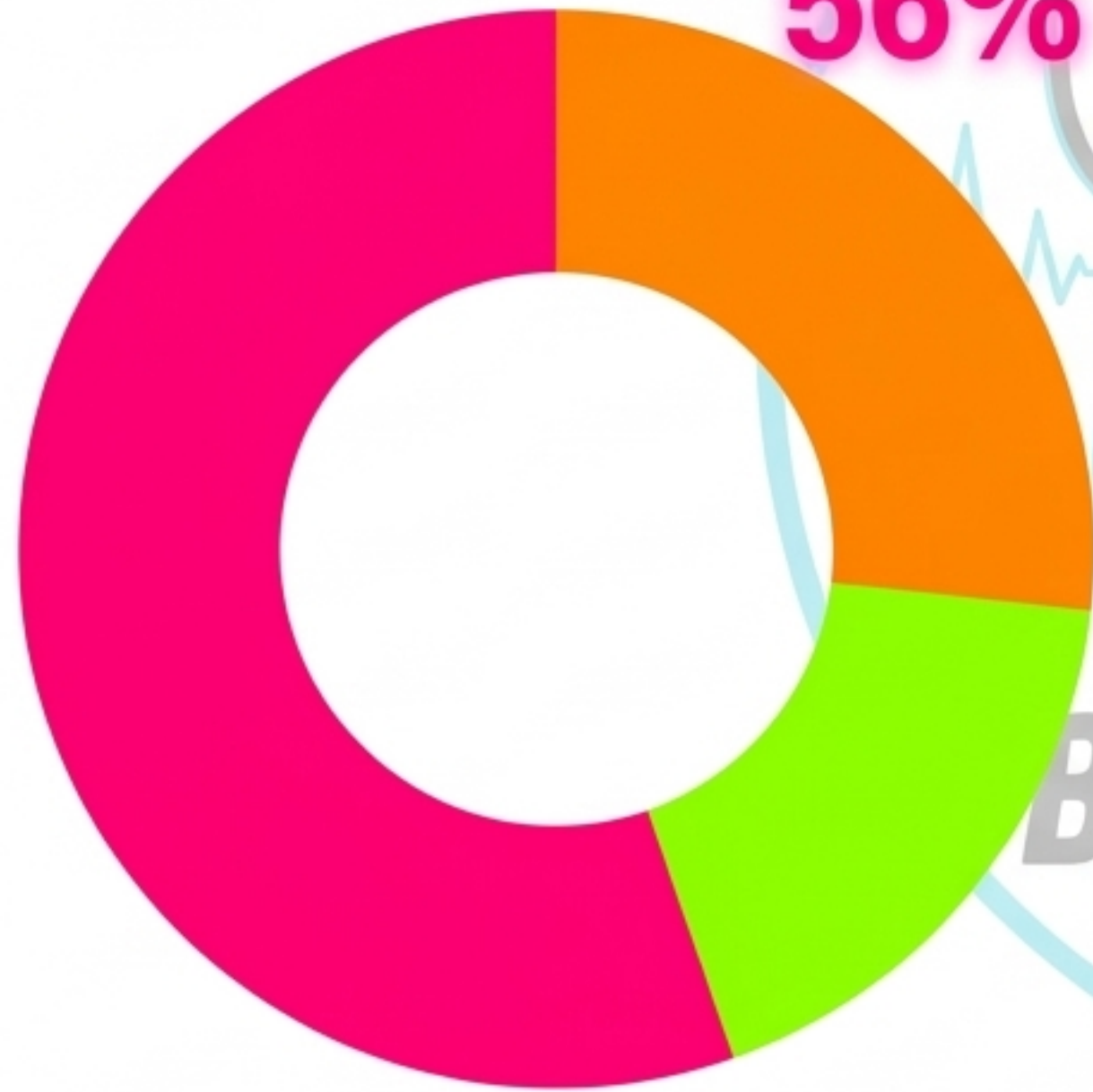
Fase 3: Postoperatorio

Recuperación, manejo del dolor, inicio de tolerancia y fluidoterapia.

BADBEAR.ME



Evaluación Preoperatoria: El Eje Clínico



56% Rendimiento Diagnóstico
Historia Clínica Minuciosa (Anamnesis, factores de riesgo, comorbilidades silentes).

17% Rendimiento Diagnóstico
Examen Físico Completo (Evaluación holística: corazón, pulmones, riñones, cerebro; no solo el abdomen).

< 5% Rendimiento Diagnóstico
Exámenes de Laboratorio y Auxiliares.



**Cero empirismo. No existe el 'por si acaso' en cirugía.
Cada acción y examen solicitado debe responder a un
objetivo fisiológico o logístico claro.**

Batería de Exámenes: ¿Por qué y Para qué?

Evaluación General

Hemograma (Detecta reacciones leucemoides silentes), Glucosa, Creatinina, Examen de Orina.

Objetivo: Identificar diabetes o falla renal oculta.

Hemostasia y Sangrado

Plaquetas ($>150,000$), TP, TTP, Fibrinógeno (200-400 mg/dL).

Objetivo: Evaluar riesgo de hemorragia; necesidad de Vitamina K o transfusión.

Perfil Hepático

Bilirrubinas, Transaminasas, Fosfatasa Alcalina.

Objetivo: Garantizar un metabolismo óptimo de los fármacos anestésicos.

Bioseguridad

VIH, Hepatitis, Sífilis.

Objetivo: No es cancelar la cirugía, sino activar protocolos extremos de bioseguridad en el quirófano.



Estratificación de Riesgo: Vía Aérea (Mallampati)



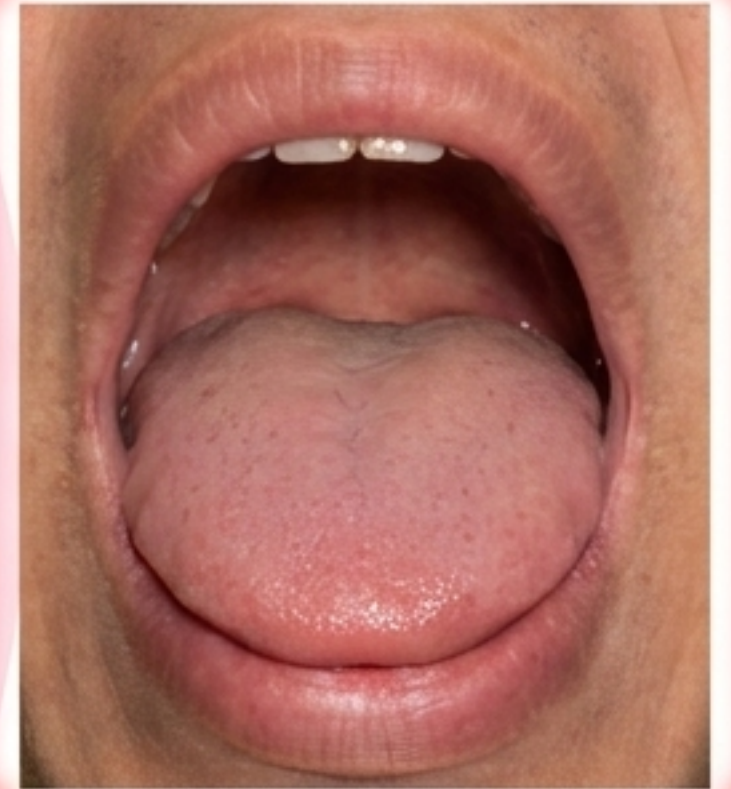
Clase 1: Visibilidad total. Paladar blando, úvula, pared posterior de faringe y pilares visibles. Intubación ideal.



Clase 2: Pilares ocultos. Visibilidad de paladar blando y úvula.



Clase 3: Base de la úvula y paladar blando visibles. Lengua dificulta el paso.



Clase 4 (ALERTA): Solo paladar duro visible. Totalmente ocluido por el dorso de la lengua. **Riesgo extremo (cuello corto/obesidad); puede requerir intubación**

Estratificación de Riesgo: Estado Físico (Clasificación ASA)



Nota:

Score de Goldman: Riesgo cardiovascular preoperatorio.
Score >25 = 56% mortalidad.

El Consentimiento Informado (Ética y Humanización)

Responsabilidad Directa: Debe realizarlo el cirujano principal, NO es delegable al azar.

Transparencia: Explicar diagnóstico, alternativas de tratamiento, metas reales y manejo de posibles complicaciones.

Autonomía Absoluta: El paciente tiene derecho a desistir de la cirugía en cualquier momento, incluso tras firmar.

Mandato Ético: Erradicar la 'Despersonalización'. El paciente tiene nombre e historia. Está prohibido reducirlo a un diagnóstico o un número.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Nombre: Juan Carlos Apellido: ... Edad: ... Sexo: ...

Profesión: ... Dirección: ...

Firma del paciente: Juan Carlos Firma del médico: Dr. Juan Carlos

Fecha: 15/11/2020

1. Fomento de consentimiento informado.

1. Genuidad verídica. El paciente conoce la naturaleza de la intervención de su cuerpo, de los riesgos que conlleva, de los beneficios que se esperan de la misma.

2. Brevedad y claridad. El paciente conoce de la naturaleza, metas y procedimientos de la intervención.

3. No voluntariedad. El paciente conoce los riesgos que conlleva la intervención de su cuerpo, de los beneficios que se esperan de la misma, de los riesgos que conlleva la intervención de su cuerpo, de los beneficios que se esperan de la misma.

4. Si como doble efecto. Si el paciente, al aceptar la intervención de su cuerpo, de los riesgos que conlleva la intervención de su cuerpo, de los beneficios que se esperan de la misma, de los riesgos que conlleva la intervención de su cuerpo, de los beneficios que se esperan de la misma.

5. Consentimiento informado. El paciente conoce la naturaleza de la intervención de su cuerpo, de los riesgos que conlleva la intervención de su cuerpo, de los beneficios que se esperan de la misma.

- Temporario de acuerdo para tratamiento y verificación de la cirugía, personaliza un historial.

- El consentimiento es una decisión voluntaria de la persona que se opera.

- Es un consentimiento informado.

- Don Juan Carlos

~~CAMA 8~~

Fases y Manejo del Postoperatorio

Inmediato (0-24h)

Recuperación anestésica (2h), control estricto de signos vitales, manejo del dolor, diuresis, y vigilancia de sangrado/drenajes.

Mediato (Días 1-3)

Retorno de la motilidad intestinal, inicio de tolerancia oral progresiva, retiro gradual de drenajes, y deambulación precoz.

Tardío

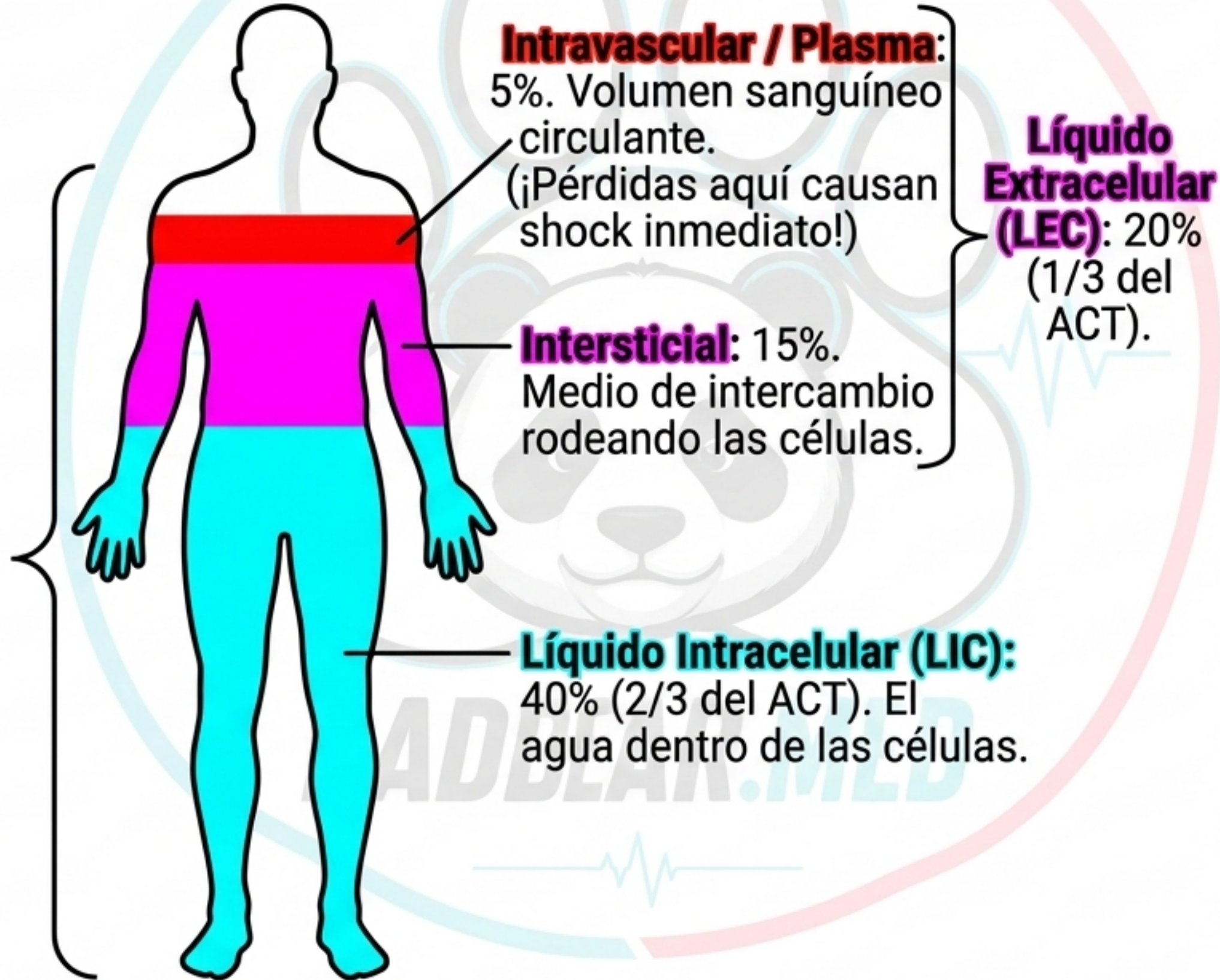
Alta hasta recuperación. Control ambulatorio. Reintegración total a actividades de la vida diaria y laboral.



Pilares de Éxito: Deambulación temprana, retiro precoz de sondas, hidratación estricta y control de fluidos.

Fisiología de Compartimentos: Distribución del Agua

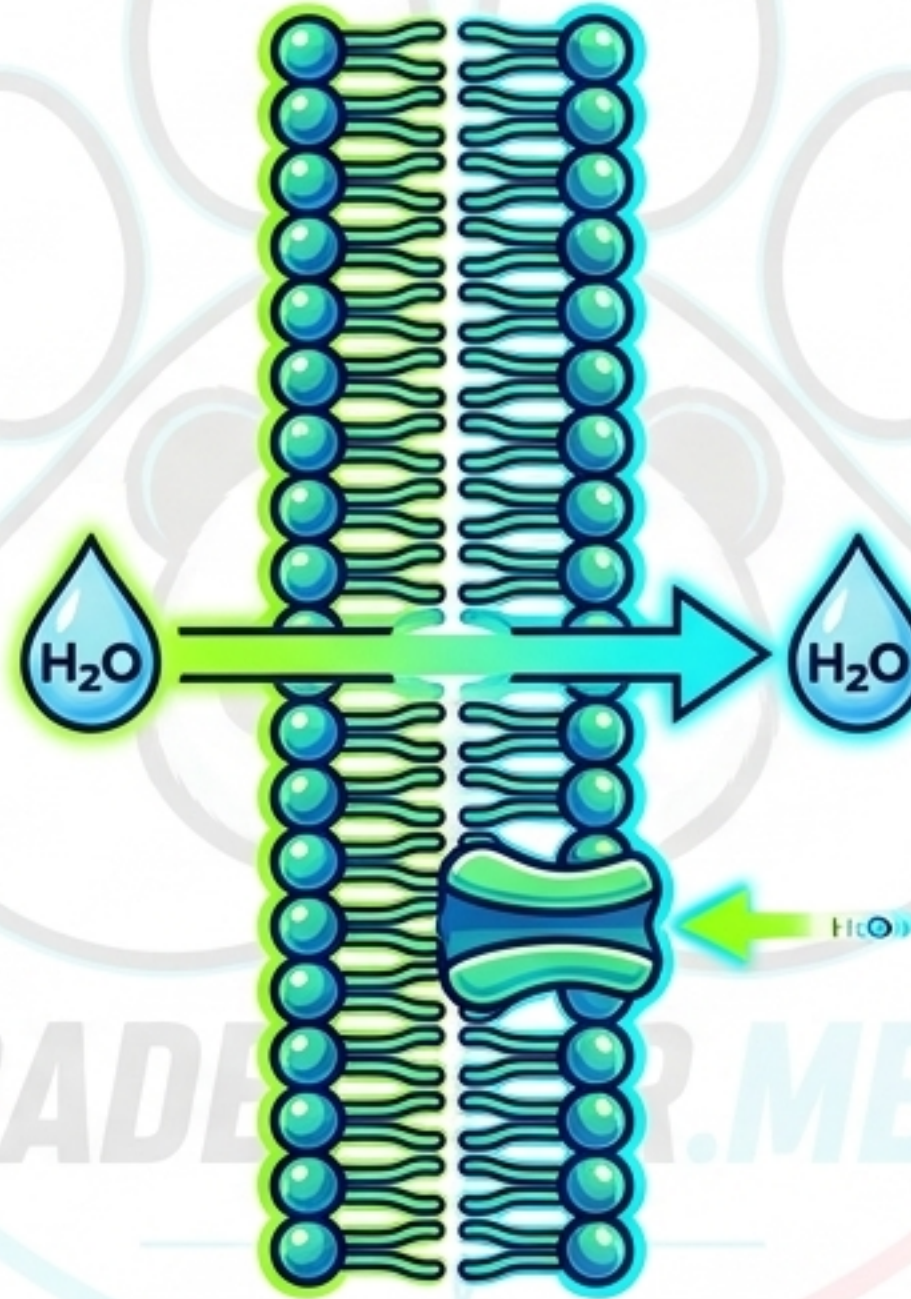
Agua Corporal Total (ACT):
60% del peso corporal.
(Varía: 50% en mujeres por tejido adiposo, 80% en neonatos).



Dinámica de Compartimentos: Sodio y Potasio

Líquido Intracelular (LIC)

- **Catión Principal:** Potasio (K^+)
- **Otros componentes:** Magnesio (Mg), Fosfatos, Proteínas.
- **Función:** Contracción muscular, función cardíaca y transmisión neuromuscular.



Líquido Extracelular (LEC)

- **Catión Principal:** Sodio (Na^+)
- **Aniones:** Cloro (Cl^-), Bicarbonato. Ba^-
- **Función:** Determina la osmolaridad y tonicidad. Mueve el agua por ósmosis.

La Regla de Ósmosis: El agua siempre se desplaza hacia el compartimento con mayor concentración efectiva de solutos (dictado primariamente por el Sodio).

Balance Hídrico: Ingresos vs. Egresos

Ingresos

Vía oral, nutrición enteral, fluidos IV, hemoderivados, medicamentos diluidos.



Egresos

- **Cuantificables:** Orina, vómitos, sangre, drenajes, aspiración nasogástrica.
- **Insensibles:** Sudoración, respiración, pérdida por piel.



Clasificación de Deshidratación (Pérdida de ACT)

- **Leve:** Pérdida < 5% del agua corporal total (Ej: 70kg pierde ~2 Litros). Principalmente del intersticio.
- **Moderada:** Pérdida < 10% del ACT (Ej: 70kg pierde ~4.2 Litros).
- **Severa:** Pérdida > 10% del ACT. Riesgo inminente de shock hipovolémico.

Masterclass Matemática: Requerimientos de 24 Horas

(Ejemplo base: Paciente de 70 kg sin pérdidas anormales)

1. Volumen de Agua: 30 - 50 cc / kg / día (Promedio 40 cc).

$$70 \text{ kg} \times 40 \text{ cc} =$$

$$2,800 - 3,000 \text{ ml}$$

2. Requerimiento de Sodio (Na⁺): 2.5 mEq / kg / día.

$$70 \text{ kg} \times 2.5 =$$

$$175 \text{ mEq}$$

3. Requerimiento de Potasio (K⁺): 1.5 - 2 mEq / kg / día.

$$70 \text{ kg} \times 1.5 =$$

$$105 - 140 \text{ mEq}$$

4. Velocidad de Infusión (Gotas/min): Volumen Total / (Horas x 3).

$$3,000 \text{ ml} / (24\text{h} \times 3) =$$

$$41.6 \text{ gotas/min}$$

Matriz de Cristaloideos I: Soluciones Salinas

Cloruro de Sodio 0.9% (Isotónico)



- **Composición:** 154 mEq Na⁺, 154 mEq Cl⁻ (Osmolaridad: 308 mOsm/L).

- **Uso Quirúrgico:** Expansión de volumen intravascular, reposición en hipovolemia.

- **Riesgo Clínico:** Administrar en grandes cantidades causa acidosis metabólica hiperclorémica.

Cloruro de Sodio 0.45% (Hipotónico)



- **Composición:** 77 mEq Na⁺, 77 mEq Cl⁻ (Osmolaridad: 154 mOsm/L).

- **Uso Quirúrgico:** Aporte de agua libre en situaciones de hipernatremia.

- **CONTRAINDICACIÓN:** NUNCA usar como reanimación inicial en shock (el líquido abandona el espacio intravascular celularmente).

Matriz de Cristaloides II: Dextrosa y Potasio (ALERTA)

Dextrosa 5% (Vehículo y Aporte)



Cloruro de Potasio (KCl 20%)

Ampollas de 10ml / 27 mEq



- **Contiene** 50g glucosa/L (170 kcal/L). Cero electrolitos.
- **Uso real:** Vehículo para diluir medicamentos/antibióticos o aportar agua libre tras metabolizar la glucosa. No previene catabolismo (requerimiento diario >2500 kcal).
- **Advertencia:** Inútil para reanimar pacientes en shock o hemorragia.



PELIGRO LETAL: JAMÁS administrar en bolo intravenoso directo. Causa arritmias fatales y paro cardíaco inmediato.

Protocolo: Debe ser estrictamente diluido en sueros de volumen e infundido lentamente bajo monitorización.



Excelencia Quirúrgica

*"Un buen manejo pre y postoperatorio
refleja el arte quirúrgico en la satisfacción
del paciente, engrandeciendo la
nobleza de la cirugía."*

Encuéntranos y únete a la comunidad BADBEAR.MED en:

